# Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell terepi alkalmazása gyógypedagógiai környezetben

*Módszertani beszámoló*

**Szerző:** Ódor Antal, független kutató

**DOI:** 10.5281/zenodo.18076570

**ID:** https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor-antal@research.hu

Budapest, 2025. augusztus 26. - október 11.

**Absztrakt**

A tanulmány egy öthetes, intenzív terepmunka tapasztalatait összegzi, amelynek célja az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell gyakorlati validációja volt egy gyógypedagógiai intézmény alsó tagozatos, speciális nevelési igényű tanulókat integráló csoportjában. Az ESV-modell a mentális működést dinamikus, funkcionális egyensúlyvesztésként értelmezi, és a tüneti beavatkozás helyett a rendszer önszabályozó képességének helyreállítására fókuszál. A terepi megfigyelések és kvalitatív jegyzetek alapján a módszer különösen hatékonynak bizonyult a traumatikus hiány, a dezorganizált kötődés és a tanult patológiás minták kezelésében. A beavatkozások gyors és stabil csoportszintű változást eredményeztek, az önszabályozás, a bizalom és a koregulációs készségek terén.

## Bevezetés

A gyógypedagógiai gyakorlatban egyre gyakoribb, hogy a segítők komplex érzelmi, viselkedési és traumaalapú problémákkal küzdő gyermekekkel dolgoznak. A hagyományos tünetorientált megközelítések (pl. DSM, BNO) statikus kategóriákban gondolkodnak, amelyek kevéssé tükrözik az egyéni pszichés folyamatok dinamikáját. Az ESV-modell egy funkcionális, rendszerszintű keret, amely szerint minden viselkedés érzelmi (E) és stressz-eredetű (S) tényezők kölcsönhatásából (V) születik. A modell célja, hogy a pedagógus, gyógypedagógus és mentálhigiénés segítő a viselkedés mögötti folyamatokat értse meg és ezekre reagáljon, nem csupán a tünetre.

## Módszertan

A terepi szakasz egy öthetes, kvalitatív jellegű megfigyelésen alapult. A kutatási helyszín egy gyógypedagógiai intézmény alsó tagozata volt, ahol a tanulók többsége valamilyen fejlődési, érzelmi vagy kötődési nehézséggel küzdött. Az adatgyűjtés terepi naplók, reflektív jegyzetek és intervenciós leírások formájában történt. A tanulmány nem tartalmaz semmilyen beazonosítható személyes adatot, minden esettípus összevont, anonimizált formában jelenik meg. A kutatás kvalitatív és feltáró jellegű volt, célja a modell gyakorlati alkalmazhatóságának és hatékonyságának validálása terepi környezetben.

**Eredmények és beavatkozási típusok**

***A traumatikus hiány kezelése***

A szülői veszteségből fakadó érzelmi hiány gyakran agresszív vagy orális (pl. fokozott evés) viselkedésben jelent meg. Az ESV-intervenció itt a biztonságos érzelemkifejezés új rítusának tanítását célozta, amely lehetőséget adott a hiány megélésére és korrekciójára. Az érzelemnevesítés („hiányzik valaki", „szomorú vagyok") és a fizikai koreguláció kombinációja gyors javulást eredményezett az agresszió és feszültségszint csökkenésében.

***Dezorganizált kötődés pedagógiai keretezése***

Az ambivalens kötődési mintázatot mutató gyermekeknél a direkt szeretet paradox módon stresszt generált. Az áttétel-alapú beavatkozás során a pedagógus irányított érzelmi expozíciót hozott létre, amelyben a gyermek biztonságosan élhette meg a dühöt és veszteséget. A kapcsolat megtartása a düh után korrekciós élményként működött, és jelentős kötődési stabilizálódást eredményezett.

***Tanult patológiás minták megszakítása***

Az instrumentális, tanult viselkedések esetében (pl. üvöltés, mint eszköz) az ún. egó-trigger technika hozott áttörést. A „kihívásnyelv" („Biztos, hogy csak ennyit tudsz?") aktiválta a kompetenciaérzést, így megszakadt a pszichés kényszerhurok, a viselkedés önfenntartó jellege.

A modell hatékonyságának indikátorai

- Gyors rendszer-stabilizálódás: A korábban kaotikus, szétesős csoportdinamika 2-3 hét alatt önszabályozó rendszerré alakult.
- Szétesések megszűnése: A viselkedéses kontrollvesztések jelentősen ritkultak, több esetben teljesen megszűntek.
- Önszabályozás megjelenése: A gyerekek egy része képes lett az érzelem- és stresszkezelésre külső segítség nélkül.
- Autentikus érzelemkifejezés: A destruktív viselkedések helyét fokozatosan valódi, elfojtott érzelmek (pl. sírás, bújás, bocsánatkérés) vették át.

**Megbeszélés**

A terepi tapasztalatok alapján az ESV-modell nem csupán intervenciós módszer, hanem diagnosztikai keret is. A viselkedés értelmezése az érzelem-stressz tengelyen keresztül rendszerszintű szemléletet biztosít, amely a gyógypedagógiai munkát kiterjeszti az érzelmi edukáció és a stresszreguláció irányába. A modell különlegessége, hogy a koregulációt - vagyis a segítő és gyermek közötti közös érzelmi szabályozást - tanítható, tudatos folyamatként kezeli. Ezáltal a pedagógus nem csak viselkedésformáló, hanem érzelmi mintázatkorrekciót végző segítővé válik. Az eredmények alátámasztják, hogy a modell alkalmazása jelentősen gyorsabb stabilizálódást eredményez, mint a hagyományos viselkedésirányító technikák.

**Konklúzió**

Az öthetes terepi vizsgálat tapasztalatai alapján az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell a gyógypedagógiai gyakorlatban magas hatékonyságú, rövid távon is eredményt mutató megközelítés. Az ESV-modell nem helyettesíti a pszichológiai vagy orvosi ellátást, hanem kiegészíti azt a pedagógiai térben. A további kutatásoknak kvantitatív irányban kell folytatódniuk, a modell hosszú távú hatékonyságának statisztikai validálására.

**Hivatkozások**


**Bowlby, J. (1969).** *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.

**Ódor, A. (2020).** *Ambivalencia*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18062030

**Ódor, A. (2024).** *Az ESV-Modell: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés kapcsolata a függőségek mechanizmusában*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067060

**Ódor, A. (2024).** *Pszichés kényszerhurok: Egy trauma-indukált mentális mechanizmus dinamikája*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067292

**Schore, A. N. (2003).** *Affect regulation and the repair of the self*. W. W. Norton & Company.

**Siegel, D. J. (2012).** *The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are*. Guilford Press.

**Van der Kolk, B. A. (2014).** *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.